

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (PSS-10)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Global de Estrés Psicológico y Percepción de Control

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Estrés Percibido de 10 Ítems (PSS-10).
Nombre Original (Inglés)	<i>Perceived Stress Scale - 10 Item Version (PSS-10)</i>
Autores Originales	Sheldon Cohen, Tom Kamarck y Robin Mermelstein (1983); Cohen y Williamson (1988).
Adaptaciones Españolas	Remor (2006, validación europea de referencia); González y Landero (2007, México); Campo-Arias et al. (2009).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Autoinforme de estrés general y capacidad de afrontamiento.
Tipo de Instrumento	Escala de autoinforme de 10 reactivos politómicos de 5 anclajes (0 = Nunca a 4 = Muy a menudo).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 14 años). Aplicable en salud mental, medicina preventiva y laboral.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para uso académico, clínico e investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO PSICOSOCIAL

La PSS-10 se fundamenta en el modelo transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1984), el cual postula que el impacto del estrés no depende únicamente de la magnitud objetiva de los acontecimientos vitales, sino de la **evaluación cognitiva** que realiza la persona sobre la impredecibilidad, incontrolabilidad y sobrecarga de las demandas del entorno en relación con sus propios recursos de afrontamiento percibidos.

A diferencia de los inventarios de sucesos vitales acumulados (como la escala de Holmes y Rahe), la PSS-10 no asume el peso de sucesos específicos predefinidos, sino que mide directamente el **estado afectivo-cognitivo resultante** de la valoración subjetiva global experimentada durante el último mes. Su robustez metodológica radica en captar simultáneamente la sensación de verse desbordado y la confianza en la capacidad de manejo personal, convirtiéndola en el estándar de oro internacional para investigar el eje estrés-enfermedad.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL (MODELO BIFACTORIAL DE COHEN)

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Psicológica
1. Percepción de Sobre-carga / Descontrol	1, 2, 3, 6, 9, 10	0 a 24	Evalúa sentimientos de falta de control, nerviosismo, tensión acumulada y percepción de dificultades insuperables.
2. Autoeficacia Percibida (Invertidos)	4, 5, 7, 8	0 a 16	Capacidad subjetiva de control, seguridad para resolver problemas y sensación de que las situaciones marchan favorablemente.
PUNTUACIÓN TOTAL PSS-10	1 al 10	0 a 40	Índice multidimensional global de distrés y sobrecarga percibida en el último mes.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.82 a 0.86 en validación española (Remor, 2006) y coeficientes omega jerárquico > 0.85 en muestras hispanohablantes.
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.72$ a 0.85 en intervalos de dos a cuatro semanas, demostrando estabilidad adecuada para un constructo de estado sensible al cambio.
Validez Concurrente y Criterio	Correlaciones positivas elevadas con escalas de ansiedad (STAI $r = 0.65$; BAI $r = 0.61$), sintomatología depresiva (BDI-II $r = 0.68$) y problemas psicosomáticos.
Validez Divergente	Correlaciones negativas significativas con autoestima (Rosenberg $r = -0.54$), optimismo disposicional y medidas de calidad de vida relacionada con la salud.
Invarianza de Medida	Invarianza factorial configural, métrica y escalar comprobada por sexo y grupos de edad en población española y latinoamericana.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ÍTEMS

Las respuestas corresponden a una escala graduada de 5 puntos referida al **último mes**:

- **0** = Nunca | **1** = Casi nunca | **2** = De vez en cuando / A veces | **3** = A menudo | **4** = Muy a menudo.
- **Inversión Obligatoria de Ítems Positivos:** Los reactivos **4, 5, 7 y 8** expresan afrontamiento positivo y deben invertirse antes del cómputo total:

0 -> 4 | 1 -> 3 | 2 -> 2 | 3 -> 1 | 4 -> 0

- **Cálculo del Total:** Suma de los 6 ítems directos más los 4 ítems invertidos. Rango de puntuación: **0 a 40 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (REMOR, 2006; COHEN, 1988)

Nivel	Puntuación	Estado Clínico y Significación	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo	0 a 13	Estrés percibido bajo / basal	Demandas cotidianas percibidas dentro del rango normal y manejable. Fomentar hábitos saludables de autocuidado.
Moderado	14 a 26	Estrés moderado habitual	Tensión psicosocial cotidiana significativa. Se recomienda monitorización, psicoeducación en manejo del tiempo y estilos de vida.
Alto	27 a 40	Estrés severo / Clínicamente crítico	Sobrecarga severa y colapso de recursos de afrontamiento. Elevado riesgo de depresión, trastorno adaptativo o somatizaciones. Intervención clínica prioritaria.

DISTINCIÓN NORMATIVA SEGÚN GÉNERO: Los baremos poblacionales españoles (Remor, 2006) reportan medias ligeramente más altas en mujeres ($M = 20.2$; $DT = 6.8$) que en varones ($M = 17.8$; $DT = 6.4$), atribuidas a la doble carga de roles psicosociales y mayor sensibilidad a la sobrecarga percibida.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

DISOCIACIÓN ENTRE SOBRECARGA Y AUTOEFICACIA:

- **Sobrecarga alta con Autoeficacia conservada:** La persona percibe exigencias extremas pero mantiene la creencia en sus habilidades; el abordaje debe centrarse en modificaciones ambientales, límites laborales y modulación de estresores externos.
- **Sobrecarga alta con Autoeficacia colapsada (Perfil de Agotamiento):** La persona siente que no puede controlar ningún aspecto de su vida; alto riesgo de indefensión aprendida y episodio depresivo. Requiere intervención cognitivo-conductual en resolución de problemas y reactivación conductual.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ÁMBITO SANITARIO

Paciente: Mujer de 41 años, médica de urgencias hospitalarias, derivada a salud laboral por insomnio de conciliación persistente, cefaleas tensionales frecuentes y sensación de bloqueo ante la toma de decisiones clínicas en guardias nocturnas.

Puntuación PSS-10 Total: 31 puntos (Rango Alto — Nivel Clínicamente Crítico).

• **Desglose factorial:** Factor Sobrecarga = 20/24 (ítems 1, 2, 3, 6, 9 y 10 en puntuaciones máximas de nerviosismo y falta de control); Factor Autoeficacia Invertida = 11/16 (pérdida severa de confianza en su capacidad para resolver dificultades cotidianas).

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno Adaptativo con Ansiedad Mixta y Burnout incipiente. Se diseña un plan terapéutico con reasignación temporal de turnos sin guardias continuadas, entrenamiento en desactivación psicofisiológica y terapia cognitivo-conductual focalizada en perfeccionismo disfuncional y límites asertivos. A los 2 meses de seguimiento, el PSS-10 se redujo a 16 puntos (nivel moderado adaptativo), con remisión completa de la cefalea e insomnio.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: INSTRUMENTO NO DIAGNÓSTICO

La PSS-10 evalúa el nivel de estrés percibido pero no diagnostica trastornos psiquiátricos específicos. Puntuaciones ≥ 27 exigen cribado formal de depresión mayor, ansiedad y burnout mediante escalas como PHQ-9 o GAD-7.

EVALUACIÓN DE IDEACIÓN SUICIDA

El estrés severo sostenido es un factor desencadenante de conductas autolíticas. Ante puntuaciones extremas, el clínico debe explorar de manera proactiva la presencia de desesperanza e ideación de muerte.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385–396.
2. Cohen, S., & Williamson, G. M. (1988). Perceived stress in a probability sample of the United States. In S. Spacapan & S. Oskamp (Eds.), *The social psychology of health* (pp. 31–67). Sage Publications.
3. Remor, E. (2006). Psychometric properties of a European Spanish version of the Perceived Stress Scale (PSS). *The Spanish Journal of Psychology*, 9(1), 86–93.
4. González, M. T., & Landero, R. (2007). Factor structure of the Perceived Stress Scale (PSS) in a sample from Mexico. *The Spanish Journal of Psychology*, 10(1), 199–206.